Клинические рекомендации

Полипозный риносинусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J33.0** — Полип полости носа **J33.1** — Полипозная дегенерация синуса **J33.8** — Другие полипы синуса **J33.9** — Полип носа неуточненный
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/890_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 4

2.3 Классификация 4

2.4 Шкала Lund–Kennedy 4

2.5 Клиническая картина 5

2.6 Жалобы и анамнез 5

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Степень тяжести 6

3.3 Осмотр оториноларинголога 6

3.4 Передняя риноскопия 6

3.5 Эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки 6

3.6 Компьютерная томография околоносовых пазух 6

3.7 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 7

3.8 Патолого-анатомическое исследование 7

3.9 Цитологическое исследование 7

3.10 Консультации пульмонолога и аллерголога-иммунолога 7

3.11 Исследование скорости мукоцилиарного транспорта (сахариновый тест) 7

4. Лечение 7

4.1 Ограниченный полипоз (полипы в пределах среднего носового хода) 7

4.2 Системные кортикостероиды 8

4.3 Блокаторы лейкотриеновых рецепторов 8
4.4 Системная антибактериальная терапия 8
4.5 Тяжёлое течение, сочетание с бронхиальной астмой: генно-инженерная биологическая терапия 8
4.6 Неэффективность медикаментозной терапии, распространённый полипоз: хирургическое лечение 10
4.7 Послеоперационное ведение 10
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации **10**
5.1 Показания к госпитализации 11
6. Источник и актуальность **11**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Диагноз устанавливают на основании:
  1. жалоб и анамнеза;
  2. данных осмотра;
  3. передней риноскопии;
  4. эндоскопии полости носа и носоглотки;
  5. компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух.
- Препаратом выбора является мометазон в форме назального спрея по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс **3–6 месяцев**. Если симптомы не уменьшаются **в течение 5–6 недель**, рассматривают вопрос о хирургическом лечении.
- Системная антибактериальная терапия при полипозном риносинусите не рекомендуется.
- Генно-инженерная биологическая терапия (дупилумаб, омализумаб или меполизумаб) рекомендуется:
  1. при тяжёлом течении;
  2. при сочетании с бронхиальной астмой.
- Показания к хирургическому лечению:
  1. неэффективность медикаментозной терапии;
  2. распространённый полипоз.

  Оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия.
- В течение первого года после операции пациента осматривают **каждые 3 месяца**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Полипозный риносинусит (ПРС): фенотип хронического риносинусита, гетерогенное по этиологии и патогенезу хроническое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП) продолжительностью **более 12 недель**.

Сопровождается

1. ремоделированием слизистой оболочки;
2. образованием и рецидивирующим ростом полипов.

Полипы носа представляют собой доброкачественные новообразования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Т2-эндотип ПРС характеризуется воспалением с эозинофилией крови или ткани либо с повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е (IgE). К нему относятся эозинофильный хронический риносинусит, аллергический грибковый риносинусит и центральная компартментная атопическая болезнь (CCAD), то есть изолированные полипозные изменения слизистой оболочки верхней и средней носовых раковин и задневерхних отделов перегородки носа у пациентов с установленной аллергией к ингаляционным аллергенам.

2.2 Этиология и патогенез

В развитии ПРС участвуют

1. нарушения врождённого и адаптивного иммунитета;
2. аллергия;
3. генетически обусловленные заболевания: иммунодефициты, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия;
4. изменения внутриносовой анатомии;
5. бактериальная, грибковая и вирусная инфекция.

Вместе или по отдельности эти факторы поддерживают хроническое воспаление слизистой оболочки носа, которое приводит к образованию полипов и рецидивам.

Эозинофильный и неэозинофильный эндотипы ПРС различаются клиническими проявлениями, течением и ответом на лечение.

Из анатомических изменений у больных риносинуситом наиболее часто встречаются искривление перегородки носа (36%), concha bullosa (30%), клетки Оноди (12%) и клетки Галлера (6%), реже парадоксальный изгиб средней носовой раковины (3%) и пневматизация крючковидного отростка (2%).

2.3 Классификация

Единая классификация отсутствует. По клиническим и эндоскопическим данным выделяют три стадии:

1. полипы ограничены средним носовым ходом;
2. полипы выходят за пределы среднего носового хода;
3. полипы обтурируют соответствующую половину носа.

Для эндоскопической оценки применяется шкала Lund–Kennedy: полипы, отёк и отделяемое оцениваются отдельно справа и слева, каждый признак от 0 до 2 баллов.

2.4 Шкала Lund–Kennedy

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Полипы	Полипы отсутствуют	Полипы в пределах среднего носового хода	Полипы распространяются за пределы среднего носового хода
Отёк	Отёк отсутствует	Умеренный отёк	Значительный отёк
Отделяемое	Отделяемое отсутствует	Прозрачное отделяемое	Густое гнойное отделяемое

Шкала Lund–Mackay по данным КТ, справа и слева отдельно

1. каждая пазуха: 0 баллов без изменений, 1 балл при частичном затенении, 2 балла при тотальном затенении;
2. остиомеатальный комплекс: 0 баллов, если интактен, 2 балла при обтурации;
3. сумма для каждой стороны от 0 до 12 баллов, общая сумма от 0 до 24.

> Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не совпадает с текстом раздела 1.5. Верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны в ней дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют. Остиомеатальный комплекс в таблице оценивается в 0, 1 или 2 балла, в тексте только в 0 или 2 балла. В строке «Общее количество баллов» справа указаны 0, 7 и 14, слева 0, 1 и 2, хотя согласно ключу под таблицей сумма составляет от 0 до 12 на сторону. Расчёт следует проводить по тексту раздела 1.5.

По гистологическому строению различают отёчные полипы с преимущественно эозинофильной инфильтрацией (70–85% клеток), фиброзные полипы с преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желёз и полипы с атипией стромы.

2.5 Клиническая картина

Основные симптомы

1. заложенность носа;
2. слизистые или слизисто-гнойные выделения, стекание отделяемого по задней стенке глотки;
3. ощущение тяжести и давления в области носа и в проекции околоносовых пазух;
4. диффузная головная боль;
5. снижение или отсутствие обоняния.

В ряде случаев

1. жжение и раздражение в горле, кашель, охриплость;
2. недомогание, снижение работоспособности, сонливость.

Необходимо оценить выраженность и продолжительность симптомов. При обострении симптомы усиливаются.

2.6 Жалобы и анамнез

Группы жалоб

1. назальные: затруднённое носовое дыхание, выделения из носа, снижение или отсутствие обоняния;
2. болевые: лицевая боль, ощущение распирания и давления в области лица, головная и зубная боль;
3. оро- и назофарингеальные: неприятный запах изо рта, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель, заложенность или боль в ушах;
4. системные: недомогание, утомляемость, снижение работоспособности.

Такое разделение позволяет подтвердить диагноз, оценить степень тяжести и выявить факторы, влияющие на выбор тактики лечения.

При сборе анамнеза уточняют время и причины появления симптомов, последовательность их развития, выраженность и динамику, влияющие на них факторы, ранее проведённые обследования и лечение.

Отдельно выясняют

1. связь симптомов с сезонными или круглогодичными аллергенами;
2. непереносимость ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);
3. симптомы бронхиальной астмы;
4. ПРС у близких родственников;
5. одно- или двусторонний характер симптомов;
6. рецидивирующие носовые кровотечения.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии

1. **две жалобы и более**, одна из которых: заложенность носа или выделения из носа.

Возможные симптомы

1. боль и давление в проекции околоносовых пазух;
2. снижение или отсутствие обоняния.

Подтверждение

1. передняя риноскопия;
2. эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки;
3. КТ околоносовых пазух.

Диагностическая специфичность повышается при сочетании двух или более субъективных симптомов с объективными признаками заболевания (данными эндоскопии носа и лучевых методов исследования).

3.2 Степень тяжести

Степень тяжести у всех пациентов оценивают по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Пациент оценивает выраженность симптома от 0 (симптом отсутствует) до 10 баллов (максимальная выраженность).

1. лёгкое течение: **0–3 балла**;
2. умеренное: **3–7 баллов**;
3. тяжёлое: **7–10 баллов**.

Значимое влияние на качество жизни оказывают симптомы выраженностью **5 баллов и более**.

3.3 Осмотр оториноларинголога

Осмотр показан всем пациентам с подозрением на ПРС или с установленным диагнозом.

Диагностические признаки

1. болезненность при пальпации и перкуссии в проекции околоносовых пазух;
2. признаки назальной обструкции: затруднённое носовое дыхание, гнусавость;
3. вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое;
4. полипы, при длительном течении и распространённом процессе видимые уже в преддверии носа;
5. в ряде случаев расширение спинки наружного носа.

3.4 Передняя риноскопия

Выполняется всем пациентам: оценивает распространённость процесса и сопутствующую внутриносовую патологию.

3.5 Эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки

Выполняется всем пациентам для определения локализации и распространённости изменений слизистой оболочки.

Эндоскопия позволяет дифференцировать ПРС от заболеваний со сходной симптоматикой (новообразований, гипертрофии глоточной миндалины и задних концов нижних носовых раковин) и в сочетании с жалобами и анамнезом значительно повышает точность диагностики: специфичность 84%, чувствительность 66%.

3.6 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания

1. каждый пациент: оценка распространённости полипоза, состояния внутриносовых структур и костных стенок пазух.

Для повторных исследований в динамике вместо мультиспиральной КТ может применяться конусно-лучевая томография носа и околоносовых пазух, поскольку она сопровождается меньшей лучевой нагрузкой и не приводит к превышению годовой дозы на одну анатомическую зону.

3.7 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух

Показания

1. подозрение на новообразование полости носа и околоносовых пазух (дополнительно к КТ).

Рентгенография околоносовых пазух дешевле и доступнее, однако при ПРС она малоинформативна по сравнению с КТ.

3.8 Патолого-анатомическое исследование

Операционный материал исследуют у всех пациентов, чтобы дифференцировать субтипы полипозного риносинусита.

3.9 Цитологическое исследование

Выполняется всем пациентам: выявляет аллергическое воспаление и помогает выбрать тактику лечения.

Диагностические признаки

1. содержание эозинофилов **более 10%** в поле зрения свидетельствует о выраженном аллергическом компоненте.

3.10 Консультации пульмонолога и аллерголога-иммунолога

Показания

1. подозрение на бронхиальную астму или атопию: консультация пульмонолога и (или) аллерголога-иммунолога.

3.11 Исследование скорости мукоцилиарного транспорта (сахариновый тест)

Показания

1. подозрение на первичную цилиарную дискинезию: исследование скорости мукоцилиарного транспорта сахариновым тестом.

---

4. Лечение

Медикаментозное и хирургическое лечение значительно и практически в одинаковой степени улучшают качество жизни при ПРС, что подтверждает приоритетное значение адекватной медикаментозной терапии.

4.1 Ограниченный полипоз (полипы в пределах среднего носового хода)

Кортикостероиды в форме назальных спреев применяют в качестве стартовой терапии при ограниченном полипозе, когда полипы не выходят за пределы среднего носового хода, а также в пред- и послеоперационном периоде.

Мометазон, назальный спрей

1. стартовая доза: по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс **3–6 месяцев**;
2. после достижения эффекта: по 2 впрыскивания в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг в сутки).

Предпочтение отдаётся препаратам с высокой топической активностью и низкой биодоступностью, поскольку они безопаснее при длительном применении. Назальные кортикостероиды уменьшают размеры полипов и заложенность носа, улучшают обоняние, предупреждают рецидивы и повышают качество жизни.

Если симптомы не уменьшаются **в течение 5–6 недель** применения мометазона, рассматривают вопрос о хирургическом лечении.

4.2 Системные кортикостероиды

Показания к системным кортикостероидам:

1. гиперреактивность бронхов, бронхиальная астма;
2. непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов;
3. рефрактерное течение ПРС;
4. выраженная атопия;
5. уменьшение воспаления в пред- и послеоперационном периоде.

Преднизолон внутрь, в таблетках

1. недостаточный контроль симптомов назальными кортикостероидами: коротким курсом 30–60 мг в сутки, **14 дней**.

Длительный или частый приём системных кортикостероидов может повышать риск нежелательных явлений и осложнений.

4.3 Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов применяют дополнительно к системным кортикостероидам или вместо них при их непереносимости, а также при рефрактерном к кортикостероидам течении ПРС.

4.4 Системная антибактериальная терапия

Системная антибактериальная терапия при ПРС не рекомендуется, поскольку доказательств её эффективности недостаточно, тогда как риски (развитие резистентности микрофлоры, анафилаксия, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта) реальны.

Применение макролидов обсуждается в связи с их иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, однако оптимальный препарат, доза и длительность терапии не определены, поэтому сделать однозначный вывод об их эффективности при ПРС не представляется возможным.

4.5 Тяжёлое течение, сочетание с бронхиальной астмой: генно-инженерная биологическая терапия

При тяжёлом течении ПРС, а также при сочетании ПРС с бронхиальной астмой для повышения эффективности лечения и снижения риска рецидивов рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ): дупилумаб, омализумаб или меполизумаб.

Препараты ГИБТ представляют собой рекомбинантные человеческие или гуманизированные моноклональные антитела класса IgG, избирательно связывающие IgE, интерлейкины или субъединицы их рецепторов (ИЛ-5, ИЛ-4/13).

Биологическую терапию назначают при двустороннем полипозе и хирургических вмешательствах в анамнезе, если выполнены **три критерия** из пяти:

1. признаки T2-воспаления: эозинофилы в ткани не менее 10 в поле зрения, или в крови не менее 150 клеток/мкл, или общий IgE не менее 100 МЕ/мл;
2. потребность в системных кортикостероидах (2 курса и более за год или приём **более 3 месяцев**) либо противопоказания к ним;
3. значимое снижение качества жизни: SNOT-22 не менее 40;
4. аносмия по результатам исследования обоняния;
5. бронхиальная астма, требующая регулярного применения ингаляционных кортикостероидов.

Ответ на терапию оценивают по пяти критериям:

1. уменьшение размеров полипов;
2. снижение потребности в системных кортикостероидах;
3. улучшение качества жизни;
4. улучшение обоняния;
5. уменьшение влияния сопутствующих заболеваний.

Оценка ответа на генно-инженерную биологическую терапию

1. 4–5 критериев: хороший ответ;
2. 2–3 критерия: умеренный ответ;
3. 0–1 критерий: слабый ответ или его отсутствие.

Эффективность оценивают **через 6 месяцев** и **через год**. При отсутствии ответа диагноз пересматривают, лечение прекращают и при необходимости переходят на другой препарат.

Лечение длительное, при его прерывании возможен рецидив.

Беременность и лактация

1. беременность: только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода;
2. грудное вскармливание: решение о прекращении кормления или отмене препарата принимают с учётом пользы того и другого.

Решение о продолжении терапии принимается врачом с учётом тяжести заболевания и степени контроля обострений.

Режимы дозирования генно-инженерных биологических препаратов

Препарат	Доза
Дупилумаб	Подкожно 300 мг (2 мл раствора 150 мг/мл) 1 раз в 2 недели, с 18 лет. При пропуске введения лечение возобновляется как можно скорее; у пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Омализумаб	Подкожно 75–600 мг 1 раз в 2 или 4 недели; доза и кратность введения определяются исходным уровнем IgE и массой тела и корректируются при значительном изменении массы тела.
Меполизумаб	Взрослым с плохо контролируемым тяжёлым ПРС — подкожно 100 мг 1 раз в 4 недели, длительно.

4.6 Неэффективность медикаментозной терапии, распространённый полипоз: хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению для восстановления носового дыхания:

1. неэффективность медикаментозной терапии;
2. распространённый полипоз полости носа и околоносовых пазух.

Оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ) под видеоэндоскопическим контролем.

Включает

1. удаление полипозно изменённой слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух;
2. восстановление проходимости естественных соустий;
3. коррекцию анатомических нарушений: как правило, септопластику и (или) резекцию носовых раковин, а также резекцию решётчатой буллы.

В зависимости от выраженности изменений объём вмешательства может быть ограничен минимально инвазивными методиками, обеспечивающими дренирование и аэрацию околоносовых пазух.

Всем пациентам перед операцией рекомендованы кортикостероиды в форме назальных спреев, что позволяет уменьшить кровопотерю, улучшить обзор операционного поля и сократить продолжительность вмешательства.

Результат хирургического лечения во многом определяется предоперационной медикаментозной подготовкой.

4.7 Послеоперационное ведение

После любого хирургического вмешательства необходима комплексная реабилитация, направленная на восстановление носового дыхания и функции слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

Реабилитация включает

1. охранительный режим **10–14 дней и более**;
2. санацию полости носа и околоносовых пазух под эндоскопическим контролем в режиме «ирригация–аспирация» в раннем послеоперационном периоде;
3. бережное удаление плотных продуктов воспаления и фибрина для профилактики синехий;
4. при избытке вязкого отделяемого или корках орошение полости носа 0,9% раствором натрия хлорида.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с ПРС подлежат диспансерному наблюдению у оториноларинголога для своевременного выявления ухудшения на фоне лечения или рецидива после операции и коррекции терапии.

Специфическая профилактика ПРС отсутствует.

Назальные кортикостероиды **в течение 6–12 месяцев** в пред- и послеоперационном периоде у большинства пациентов:

1. уменьшают выраженность воспаления;
2. улучшают качество жизни;
3. снижают частоту рецидивов;
4. увеличивают продолжительность ремиссии.

Кратность осмотров определяют индивидуально; в течение первого года после операции осматривают **каждые 3 месяца**. При рецидиве, требующем повторного хирургического вмешательства, и при подозрении на осложнённое течение выполняют КТ околоносовых пазух.

Пациентам с ПРС необходимо ежедневное применение назальных кортикостероидов, нередко в течение всей жизни с небольшими перерывами.

> Длительность применения назальных кортикостероидов в рекомендации указана по-разному: курс мометазона 3–6 месяцев (раздел 3.1), в пред- и послеоперационном периоде 6–12 месяцев (раздел 5), в разделе 7 ежедневно, нередко в течение всей жизни.

Наблюдение оториноларинголога должно быть систематическим, не реже одного раза в 3 месяца. Результат лечения зависит не только от операции и опыта хирурга, но и от приверженности пациента лечению и выполнения им рекомендаций.

> В разделе 5 указано, что кратность обследований определяется индивидуально, а осмотры каждые 3 месяца необходимы в течение первого года после операции. В разделе 7 и в информации для пациента указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.

Основной задачей является комплексное лечение, обеспечивающее контроль симптомов и улучшение качества жизни. В ряде случаев необходимы повторные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах.

При сопутствующей бронхиальной астме показано также наблюдение аллерголога-иммунолога.

5.1 Показания к госпитализации

Обследование и лечение пациентов могут проводиться как амбулаторно, так и в условиях стационара.

Показания к плановой госпитализации:

1. функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ) с одномоментной коррекцией внутриносовых структур или без неё при отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению;
2. подбор и коррекция терапии (дневной или круглосуточный стационар);
3. проведение генно-инженерной биологической терапии.

Выписка после операции возможна при:

1. удовлетворительном общем состоянии;
2. улучшении или восстановлении носового дыхания.

Согласно алгоритму ведения пациента (приложение Б), после диагностики пациент с аллергией или бронхиальной астмой направляется к аллергологу-иммунологу или пульмонологу. При отсутствии показаний к операции наблюдение и лечение осуществляются амбулаторно; при отрицательной динамике, как и при наличии показаний, показана госпитализация в специализированный стационар для ФЭРСХ с последующим продолжением наблюдения и медикаментозного лечения.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	`890_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не соответствует тексту раздела 1.5: верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют, остиомеатальный комплекс оценивается в 0–1–2 балла вместо 0 или 2, а строка «Общее количество баллов» (0–7–14 и 0–1–2) не соответствует сумме от 0 до 12 на сторону.
- Длительность применения назальных кортикостероидов указана по-разному: 3–6 месяцев (раздел 3.1), 6–12 месяцев (раздел 5), ежедневно, нередко в течение всей жизни (раздел 7).
- Кратность наблюдения в разделе 5 определяется индивидуально, с осмотрами каждые 3 месяца в течение первого года после операции; в разделе 7 указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.